

いので、症状や胸部X線、末梢血好酸球数の変動を評価する必要がある。副腎皮質ステロイド薬漸減中の再燃はprednisolone 約10 mg/dayで、また、治療中止後も平均10ヵ月での再燃が多いと報告がある¹¹⁾。したがって、副腎皮質ステロイド薬が低用量に漸減されたときや、治療中止後も1年程度は注意が必要である。呼吸不全が重篤な場合はmethylprednisolone 1 g/dayを1～3日使用し、その後prednisolone 0.5～1.0 mg/kg/dayで経口投与を開始し、以降漸減する。投与期間は、通常は陰影の変化をみながら3～6ヵ月程度投与されることが多い。3ヵ月中止しても6ヵ月中止しても再発率はいずれも約50%程度で、有意差はなかったとの報告があるが、再治療への反応は良好である¹²⁾。長期予後は良好で死亡例の報告は少ない。

文 献

- 1) Allen JN, et al : N Engl J Med **321** : 569, 1989
- 2) Badesch DB, et al : Am Rev Respir Dis **139** : 249, 1989
- 3) Mato N, et al : Allergol Int **62** : 45, 2013
- 4) Daimon T, et al : Intern Med **44** : 811, 2005
- 5) Philit F, et al : Am J Respir Crit Care Med **166** : 1235, 2002
- 6) Cottin V, et al : Allergy **60** : 841, 2005
- 7) Rhee CK, et al : Eur Respir J **41** : 402, 2013
- 8) Shintani H, et al : Chest **117** : 277, 2000
- 9) Cordier JF, et al : Eosinophilic pneumonias. Interstitial Lung Disease, 5th Ed, Schwarz MI, et al (eds), People's Medical Publishing House, p833, 2010
- 10) 望月吉郎ほか : 日呼吸会誌 **40** : 851, 2002
- 11) Marchand E, et al : Medicine (Baltimore) **77** : 299, 1998
- 12) Oyama Y, et al : Eur Respir J **45** : 1624, 2015